

УДК:618.14-006.6-08 (574.13)

Е.Ж.Бекмухамбетов, Ж.К.Сатенова, А.Е.Ергалиев, Д.А.Телеуов, С.Т.Дюсембеков
Западно-Казахстанская государственная медицинская академия им. Марата Оспанова

Опыт применения селективной эмболизации маточных артерий в лечении местнораспространенного рака шейки матки по Актюбинской области

Аннотация. Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области диагностики и лечения, рак шейки матки продолжает занимать одну из лидирующих позиций в структуре онкологической заболеваемости женской половой сферы. В данной статье освещены результаты лечения больных с местнораспространенными формами рака шейки матки, используя гемостатическое действие рентгено-эндоваскулярной окклюзии маточных артерий. Во всех случаях наряду с гемостатическим эффектом наблюдалась частичная регрессия опухоли за счет ишемии опухолевого узла (30-40%).

Ключевые слова: Рак шейки матки, рентгено-эндоваскулярная окклюзия, маточные артерии, селективная эмболизация.

Актуальность

Рак шейки матки (РШМ) занимает второе место в мире среди злокачественных опухолей репродуктивных органов у женщин и уступает только раку молочной железы.

В последние годы обозначилась тенденция роста заболеваемости РШМ у женщин в возрастной группе до 29 лет, в которой прирост этого показателя с 1993 по 2002 г. составил 150%.

Следует, однако, констатировать факт, что довольно часто заболевшие раком шейки матки поступают в клинические учреждения тогда, когда процесс представляется распространенным и стадивируется на основании клинических данных, как Ів2 - ІV стадия болезни (FIGO). Запущенность процесса и является причиной того, что 40- 45% из числа заболевших умирают в первые годы после окончания лечения [1]. Основным клиническим проявлением ракового поражения шейки матки является кровотечение, которое препятствует проведению патогенетически обоснованной лучевой и химиотерапии [2].

Трудности остановки кровотечений вызваны особенностями органного кровоснабжения, а также развитой сетью коллатеральных анастомозов между ветвями внутренних подвздошных артерий. Консервативные мероприятия для остановки кровотечений при данной патологии малоэффективны, так как сосуды опухоли не чувствительны к действию сосудосуживающих препаратов. В то же время хирургические вмешательства, когда имеются анемия, массивная опухоль, тяжёлая сопутствующая патология, связаны с большим риском и,

как правило, не выполнимы. Лапаротомно-лигирование подвздошных сосудов травматично и далеко не всегда приводит к остановке кровотечения, так как при этом методе не прерывается кровоток по богатой сети анастомозов между ветвями подвздошных артерий. Бурное развитие ангиографии в 80-е годы XX столетия создало возможность осуществлять остановку кровотечения из распадающихся опухолей гениталий с помощью рентгено-эндоваскулярной окклюзии (РЭО) ветвей внутренних подвздошных артерий (ВПА) [3]. Использование РЭО маточных сосудов при купировании геморрагического синдрома у больных с распространенным РШМ является более эффективным и безопасным способом по сравнению с хирургической перевязкой ВПА. Важными характеристиками эмболизации маточных сосудов является малая инвазивность и травматичность, щадящее воздействие на организм женщины, отсутствие осложнений, что позволяет сократить сроки пребывания больных в стационаре и ускорить начало проведения специфической терапии РШМ [4].

Цель работы - улучшить результаты комбинированного лечения больных с местнораспространенными формами рака шейки матки (ІІ а – ІІб ст.), используя гемостатическое и регрессивное действие рентгено-эндоваскулярной окклюзии маточных артерий.

Материал и методы

В 2014г. в МЦ ЗКГМУ им. Марата Оспанова 11 пациенткам в возрасте от 27 до 52 лет, со стадией заболевания РШМ ІІа-ІІб, впервые произведена эмболизация маточных артерий. Средний возраст больных составил 43,9 лет. У всех пациенток диагноз был верифицирован. По гистологической классификации ВОЗ (1993): плоскоклеточный рак наблюдался в 8 случаях (70%), аденокарцинома у 1 (10%), у 2 пациенток железисто-плоскоклеточный рак (20%).

У 8 (70%) пациенток кровотечение было в наличии при поступлении, у 3 (30%) пациенток кровотечение развилось в процессе получения специального лечения. Следует отметить, что у 3 пациенток была клиника профузного кровотечения. Всем пациентками проведена селективная катетеризация маточных артерий по Сельдингеру, в рентген-операционной под рентгенологическим контролем с использованием катетеров Cobraи UAC для периферических сосудов. Предварительно проводилась диагностическая ангиография, позволяющей оценить характер ветвления сосудов, анатомические особенности

и наличие признаков неоваскуляризации в области малого таза. Характерной картиной опухолевого поражения шейки матки было наличие очагов гипervasкуляризации, усиленного накопления контрастного вещества. Для эмболизации артерий малого таза мы использовали Biosphere Medical (размерами – 500-700, 700-900 мкм) в среднем 2 флакона на пациента. Во всех случаях был достигнут хороший ангиографический эффект, конечной точкой являлась полное отсутствие кровотока по маточным артериям.

Время выполнения процедуры составило от 40 до 130 мин. Средняя продолжительность составила 67 мин±3.6 мин.

Результаты

Полный гемостатический эффект после проведения эмболизации маточных артерий при наличии активного кровотечения был достигнут в 100% случаях. У 1 пациентке спустя 5 дней наблюдался рецидив кровотечения и был связан с распространенностью процесса и прогрессированием на фоне лечения. У всех пациенток (100% случаев) наблюдался постэмболизационный синдром, который проявлялся в виде болевого синдрома различной степени выраженности, гипертермии, тошноты, рвоты и артралгии. Всем пациенткам в постоперационном периоде назначалась обильная гидратация, десенсибилизирующая и противорвотная терапия. При контрольном осмотре через 10 дней у всех женщин определялась частичная регрессия опухоли, с уменьшением опухолевого узла на 30-40%. Учитывая местную регрессию опухолевого процесса, всем больным проведены оперативные методы лечения, при этом 4 пациенткам произведена эндовидеохирургическая расширенная гистерэктомия (3 типа), в 7 случаях операции проведены традиционным методом.

Выводы

В подавляющем большинстве случаев артериальная эмболизация является эффективным методом остановки кровотечения из опухоли шейки матки при местнораспространенном раке. Манипуляция является несложной, легкопереносимой пациентками и проводится под местной анестезией. Наряду с гемостатическим эффектом, достигается уменьшение массы опухолевого узла, что позволяет провести специальные методы лечения.

Список литературы

1. Бохман Я.В., Лоскутова Г.П. Ошибки диагностики и лечения в онкогинекологии // Ошибки и опасности в онкологической практике. – Ташкент: Медицина, 1985. – С. 140-162.
2. Жаринов Г.М., Таразов Г.А., Суворова Ю.В. Интервенционное лечение больных раком шейки матки // Очерки лучевой терапии рака шейки матки. – Челябинск, 2002. – С. 137-143.
3. Сабекия И.М., Винокуров В.М. Роль рентгеноэндоваскулярных вмешательств в комбинированном лечении больных

местнораспространенным раком шейки матки // Вопросы онкологии. – 2004. – №5. – С. 590-594.

4. Kobayashi K., Furucawa F., Takahashi K., Murata K. Neoadjuvant intra-arterial chemotherapy for locally advanced uterine cervical cancer: clinical efficacy and factors influencing response // Cardiovasc Intervent Radiol. – 2003. – Vol. 27, №3. – P. 234-241.

ТҰЖЫРЫМ

Е.Ж.Бекмухамбетов, Ж.К.Сәтенова, А.Е.Ергалиев, Д.А.Телеуов, С.Т.Дюсембеков

Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медициналық университеті

Ақтобе облысындағы жергілікті кең тараған жатыр обыры бар науқастарды емдеудегі, селективті жатыр артерияларының эмболизациясының қолданудағы тәжірибесі

Диагностика және емнің көптеген жетістіктеріне қарамастан, онкологиялық аурулардың ішінде әйел жыныс ауруларының арасында жатыр мойны ісігі басты орынды алуды жалғастыруда. Бұл бапта жергілікті кең тараған жатыр мойны ісігімен ауыратын науқастардың емінің нәтижесі, жатыр артериясы рентгеноваскулярлы окклюзиясын пайдалану арқылы гемостатикалық әсері көрсетілген. Санақ бойынша барлық жағдайларда гемостатикалық әсерімен, ісіктің кері дамуы, ісікті түйіннің ишемиясынан болатындығы байқалған (30-40%).

Түйінді сөздер: жатыр мойны қатерлі ісігі, рентгендік эндоваскулярлы окклюзия, жатыр артерия, селективті эмболизация.

SUMMARY

E.Zh.Bekmuhambetov, Zh.K.Satenova, A.E.Ergaliev, D.A.Teleuov, S.T.Dusembekov

West Kazakhstan State Medical Academy named after Marat Ospanov

EXPERIENCE OF APPLICATION OF SELECTIVE EMBOLIZATION OF UTERINE ARTERIES IN TREATMENT OF THE LOCALLY-SPREAD CANCER OF THE NECK OF THE UTERUS ON THE AKTYUBINSK AREA

Despite the certain success achieved in the field of diagnostics and treatment, a cancer of a neck of a uterus continues to occupy one of the leading positions in structure of oncological incidence of a female genital. Results of treatment of patients with locally-spread forms of a cancer of neck of a uterus are covered in this article, using haemo static action of X-ray endovascular occlusion of uterine arteries. In all cases along with haemo static effect partial regression of a tumor at the expense of ischemia of tumoral knot (30-40%) was observed.

Key words: cervical cancer, ray endovascular occlusion, uterine artery, selective embolization.